HC: 98096660 Rut: 16.497.399-9
CP: 183096 FN: 20/05/1987.

SAMU 131

Hospital Clínico Herminda Martín

143-0299

SOLICITUD AMBULANCIA

Dg Hidronefrosis.

Nombre Paciente: Paulina Alejandra Torres Castillo

Edad: 37 años

Cuenta Corriente: 861121214

RIESGO DE CAIDAS
- [ ] Alto
- [ ] Medio
- [x] Bajo

Centro Responsabilidad/Sala/Cama: HCHM/Mod C / 65-4

Destino: Hospital de San Carlos

Motivo: Traslado

Fecha: 30/10/2024

Hora:

DOCUMENTOS
- [ ] Ficha Clínica
- [ ] Resumen Médico
- [ ] Epicrisis Enfermeria
- [ ] Interconsulta

Teléfono de Contacto del Centro Receptor: 953082959 Espos

Responsable:

REQUERIMENTOS DEL PACIENTE

- [ ] Oxigeno
- [x] Camilla
- [x] Móvil Básico
- [ ] Móvil Avanzado
- [ ] Incubadora
- [ ] Bombas de Infusión
- [ ] Aspiración
- [ ] Ventilación Asistida
- [x] Vía Venosa Preiférica
- [ ] Vía Venosa Central
- [ ] Monitorización
- [ ] Acompañante
- [ ] Otros _____

CONDICIÓN DEL PACIENTE

CATEGORIZACIÓN A [ ] B [ ] C [ ] D [ ]

PREVISIÓN Y V°B° SOME: A [ ] B [ ] C [ ] D [ ] Particular [ ] Isapre [ ]

RECEPCIÓN EN SAMU Hora _____ Fecha _____

NOMBRE Y FIRMA MEDICO TRATANTE

Dr. Carlos Zurita Martínez
Rut: 18.810.312-1
Medico Cirujano
HCHM

CLINICO HERMINDA MARTIN
DR. CIRUGÍA INDIFERENCIADA
SECTOR C
CHILLÁN

EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL	: HOSPITAL HERMINDA MARTIN	Nº EGRESO	: 96109
SERVICIO	: CIRUGIA HHM	HC	: 98096660
FECHA	: 30-10-2024	CTA. CTE.	: 861121214
		CP.	: 183096

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	:PAULINA ALEJANDRA TORRES CASTILLO			RUN	:16.497.399-9
F.Nac	:20-05-1987	Edad	:37 AÑOS, 5 MESES	Género	:Femenino
Dirección	:			Comuna	:SAN CARLOS
Previsión	:SIN INFORMACION	Teléfono	:0		
Fecha Ingreso	:2024-10-30	Fecha Egreso	:30-10-2024	Causal	:MEDICA
Condición	:VIVO	Destino	:DERIVACIÓN OTRO ESTABLECIMIENTO EN RED	Derivación	:TRASLADO OTRO HOSPITAL

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. N13.0-HIDRONEFROSIS CON OBSTRUCCION DE LA UNION URETERO-PELVICA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1. Ureterolitiasis distal derecha obstructiva 11mm x 7mm
2. PNA derecha secundaria

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. N20-N23-LITIASIS URINARIA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)
2. N13.6-PIONEFROSIS (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
3. E03-OTRO HIPOTIROIDISMO. (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente en su 1° día postop de instalación de catéter doble J y 2° día de tratamiento antibiótico con Ceftriaxona. Evolucionando favorablemente, afebril, hemodinámicamente estable y asintomática, con parámetros inflamatorios en franca disminución, por lo que se decide traslado a Hospital de San Carlos para completar esquema antibiótico endovenoso para manejo de PNA con control en CAE uro en 30 dias.

PLAN DE MANEJO:

Control CAE uro en 30 dias

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo relativo asistido
2. Regimen liviano a tolerancia
3. Sol salina 0.9% pasar a 80 cc/hr ev
4. Ceftriaxona 1 g cada 12 hrs ev
5. Dipirona 600 mg cada 12 hrs vo
6. Ondansetron 4 mg ev SOS
7. Oxibutinina 5 mg cada 24 hrs vo
8. Tratamiento cronico segun corresponda
9. Control CAE uro al alta (en 30 dias post alta en hospital de origen)
10. CSV cada 12 hrs

EXÁMENES Y RESULTADOS

En ficha

HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN CR. CIRUGIA INDIFERENCIADA SECTOR C CHILLÁN

MEDICO TRATANTE

JEFE SERVICIO